

Fecha Última Actualización: 18-06-2022 13:27:24

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Virginia Aurora Soto Opazo
Edad : 44a 0m 6d
Dirección : El Patio 0591

Rut : 13.487.965-3
Fecha Nacto : 12/06/1978
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1226211
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 5712 1711

N° Epicrisis
311869

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Urología

Fecha Ingreso : 14/06/2022 22:29

Días Estadía : 4

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 18/06/2022 13:06

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

dolor lumbar

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Tratamiento Quirúrgico Grandes Vasos Con Cec - 16/06/2022 00:00 - Paula Carolina Gaete Cartagena
Ecocardiograma Bidimensional Doppler Color Transesofágico - 16/06/2022 00:00 - Paula Carolina Gaete Cartagena

Epidemiología

Resumen Clínico

Historia clínica:

Paciente ingresa el día 15/06 por cuadro de hoy dolor lumbar derecho de comienzo súbito, con irradiación a flanco derecho, sin fiebre con vómitos. En servicio de urgencia se realiza eco en box donde se describe: coleditiasis vía biliar fina 5 mm e hidronefrosis derecha con nefrolitiasis de 2 cm. Se solicita Pielo TAC (15/06/2022): Nefrolitiasis bilateral. Acentuada hidronefrosis derecha con punto de transición a nivel de unión pieloureteral lo que sugiere estenosis pieloureteral. Cálculo de 19 mm en la pelvis renal inferior derecha. Colelitiasis.

Por esta razón ingresa servicio de urología para eventual instalación de doble J. Hoy durante la madrugada (02:48 horas) es evaluada por médico cirujano de turno (Dr. Carvajal) donde se describe paciente hipotensa, mal perfundida, y con compromiso cualitativo de conciencia. Evaluada a las 03:00 am por residente medicina interna (Dr. Opazo) quien sugiere: TAC TAP con contraste + TAC de CRB. Volemización profusa: 2000 cc en bolo. Repetir exámenes generales. Transfusión de 2 U GR. Control de SV frecuente, traslado a unidad monitorizada (Medicina sin camas)

Se realiza a las 04:29: AngioTAC con disección desde raíz aórtica. Se presenta a Dr Seguel (vascular), que indica evaluación por cardiocirugía, se presenta a Dra. Gaete (Cardiocirugía), que indica traslado a UCI para preparar cirugía de urgencia. Hablado con Dr Orellana, director hospital, que autoriza enroques de paciente para hacer cupo de UCI.

Ingresa a pabellón a primera hora del día 16/06 se instala CVC yugular izquierdo 5 lúmenes, 2 líneas arteriales, check de swan en vena yugular derecha y TOT 7.5 a 21 cm. Se conecta a CEC y se evalúa aorta con flap de disección que impresiona crónico distal a subclavia izquierda, se repara y se instala prótesis de aorta torácica.

En lo anestésico evoluciona vasopléjica, con requerimientos de Noradrenalina + Vasopresina, con deterioro función hepática evoluciona con hipoglicemia, hipocalcemia, hipokalemia en forma persistente. Se reanima dado medio interno alterado con acidosis metabólica y láctico elevado, total con 7 matraces de bicarbonato 2/3 molar + carga de potasio + politransfusión (9 U GR + 2 pool plaquetas + 2 pool crioprecipitados + 8U PFC) + infusión ácido tranexámico (3mg/k/h) + 3 frascos de octaplex. Se logra salida de CEC (CEC 189 min y clamp aórtico 92 min) y se instala CVC HD femoral en pabellón. Se constata guía metálica en vena femoral izquierda impresiona completa dentro de vena en radiografía de control realizada en pabellón en relación a intento frustrado realizado preoperatorio.

Ingresa a UCI paciente extrema gravedad, con requerimiento de DVA dosis altas (Noradrenalina 0.08 ug/k/m + Adrenalina 0.06 ug/k/m + Vasopresina 0.16 U/h), infusión de calcio, infusión de glucosa, bicarbonato, carga de potasio e infusión de ácido tranexámico. Sale de pabellón con 4 drenajes: 2 mediastínicos y drenaje pleural derecho e izquierdo, además con sonda Foley con sensor de temperatura. Se gestiona con equipo de nefrología para dar inicio TRR al ingreso. Solicito exámenes seriados y

Fecha Epicrisis : 18/06/2022 13:27

Página 1 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 15:52

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 18-06-2022 13:27:24

Página 2 de 4

continuar con reanimación.

Examen físico:

SAS 1, VMI/VC, sedación con midazolam + fentanyl.

Pupilas isocóricas.

Fría, mal perfundida.

Herida operatoria con apósito limpio y seco.

MP (+) sin ruidos agregados

RR2T no ausculto soplos

Abdomen blando, depresible, RHA ¿

EEII sin edema, sin signos de TVP, pulsos presentes y simétricos.

SNG con contenido hemático.

Imágenes:

·TAC TAP (16/06/2022): Examen limitado por artefacto de movimiento.

Aneurisma fusiforme de la aorta ascendente asociado a flap de disección que impresiona extenderse desde la aorta ascendente hasta la arteria iliaca común derecha. Se sugiere complementar con Angiotac.

No se observan hematomas intramurales.

Nefrolitiasis bilateral.

Moderada hidronefrosis derecha con cambio de calibre en la unión pieloureteral, identificando una aparente área de realce y engrosamiento con el uso de contraste. Se sugiere estudio dirigido.

Opacidades con densidad en vidrio esmerilado en el LID, nuevas con respecto a estudio previo. En el diagnóstico diferencial considerar una etiología inflamatoria - Infecciosa.

Aparente menor impregnación de la pared intestinal especialmente en colon derecho, hallazgo que puede encontrarse determinado por adquisición precoz de fase venosa. Indispensable correlacionar con antecedentes clínicos y de estimarse en realizar control evolutivo.

Resto descrito en el cuerpo del informe.

Addendum, 16-06-2022, 13:05:

Se revisan nuevamente las imágenes identificando en la fase más tardía del estudio un defecto de llene en la vena mesentérica superior (Imagen 68 Serie 18) hallazgo que se asocia a disminución de impregnación de ramas distales como signos de trombosis.

Diagnósticos al ingreso:

1.Disección aórtica toraco-abdominal

a.Reparación de flap aorta torácica + prótesis aorta torácica distal a subclavia izquierda.

b.CEC 189 min, clamp aórtico 92 min

2.Shock hemorrágico

a.Politransfundida (9 U GR + 2 pool plaquetas + 2 pool crioprecipitados + 8U PFC)

3.Falla hepática fulminante

a.Hepatitis isquémica (transaminasas 5.000 - 10.000)

4.Falla renal

a.CVC HD femoral (16/06): TRR

5.Nefrolitiasis derecha con hidroureteronefrosis, no resuelto.

Plan:

1.Hemodinamia: Inestable, requerimiento de noradrenalina + adrenalina + vasopresina en contexto de vasoplejia, con buena contractilidad miocárdica. Reanimación según predictores dinámicos de respuesta a fluidos, con control seriado con perfusión.

2.Respiratorio: En VMI/VC, ventilación protectora, sedada con midazolam + fentanyl. Se controlará con GSA.

3.Cardiológico: Buena contractilidad miocárdica en ecoTE de pabellón impresiona hiperdinámico. Se mantiene con noradrenalina + vasopresina durante CEC. A la salida de CEC con dosis bajas de adrenalina + vasopresina + noradrenalina.

4.Renal: Con falla renal en contexto de gran inflamación secundaria a disección aórtica con isquemia hepática secundaria + CEC. Se instala CVC HD en pabellón y se programa TRR al ingreso a UPC a las 07 am del día 17/06 dado falta de disponibilidad.

5.Medio interno: Manejo de hipoglicemia, hipocalcemia y acidosis, con aporte exógeno y apoyo con TRR. Control seriado con exámenes.

6.Hepático: Con falla hepática fulminante en contexto de isquemia hepática secundaria a disección aórtica.

7.Neurológico: Previo a inducción anestésica en pabellón, paciente sin alteraciones neurológicas evidentes. TAC de cerebro

Fecha Epicrisis : 18/06/2022 13:27

Página 2 de 4

Fecha Última Actualización: 18-06-2022 13:27:24

Página 3 de 4

16/06 sin alteraciones.

8.Profilaxis: IBP, por ahora sin tromboprofilaxis en contexto de paciente con coagulopatía.

Evolucion UCI:

Evolucion tórpida desde su ingreso. Incremento rápido de DVA para mantener presiones (NAD, EPI y Vasopresina), evolucionando con Falla Hepática Fulminante. Se decide HFAV de rescate, sin lograr objetivos de destete de DVA. Evoluciona con FOM titulándose DVA al alza hasta 1mcg/kg/min de NAD y EPI. Vasopresina a 0.08U/min en dosis maximas. Dado evolución, se define a paciente fuera de alcance médico y se instauran medidas para buen morir. Paciente fallece el 18.06 a ls 13hrs. Se informa a familiares.

Dx Egreso:

1. Falla Orgánica Múltiple
2. Falla Hepática Fulminante
 - a.Hepatitis isquémica (transaminasas 5.000 - 10.000)
- 3.Disección aórtica toraco-abdominal
 - a.Reparación de flap aorta torácica + prótesis aorta torácica distal a subclavia izquierda.
 - b.CEC 189 min, clamp aórtico 92 min
- 4.Shock hemorrágico
 - a.Politransfundida (9 U GR + 2 pool plaquetas + 2 pool crioprecipitados + 8U PFC)
- 5.Falla renal
 - a.CVC HD femoral (16/06): TRR
- 6.Nefrolitiasis derecha con hidroureteronefrosis, no resuelto.

Diagnóstico de Egreso

- Disecion aortica - 1. Falla Orgánica Múltiple
2. Falla Hepática Fulminante
 - a.Hepatitis isquémica (transaminasas 5.000 - 10.000)
 - 3.Disección aórtica toraco-abdominal
 - a.Reparación de flap aorta torácica + prótesis aorta torácica distal a subclavia izquierda.
 - b.CEC 189 min, clamp aórtico 92 min
 - 4.Shock hemorrágico
 - a.Politransfundida (9 U GR + 2 pool plaquetas + 2 pool crioprecipitados + 8U PFC)
 - 5.Falla renal
 - a.CVC HD femoral (16/06): TRR
 - 6.Nefrolitiasis derecha con hidroureteronefrosis, no resuelto.

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

fallecido

Plan Post Alta

fallecido

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

Fecha Epicrisis : 18/06/2022 13:27

Página 3 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 15:52

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL

DR. SÓTERO DEL RÍO

JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 18-06-2022 13:27:24

Página 4 de 4

INTERNO

Becado/Residente

Gonzalo Núñez Muñoz

Médico Tratante (Staff)